

Quadro 9.2. Vacina contra a meningite meningocócica ACWY

Tipo de vacina em uso no Brasil	Oligossacarídeo meningocócico A...10 mcg Conj. com proteína CRM197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ...6,7 a 33,3 mcg; Oligossacarídeo meningocócico C...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ...7,1 a 12,5 mcg; Oligossacarídeo meningocócico W-135...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ...3,3 a 8,3mcg; Oligossacarídeo meningocócico Y...5 mcg Conj. com proteína CRM197 de <i>Corynebacterium diphtheriae</i> ...5,6 a 10 mcg;	
Número de doses	Administrar 1 (um) reforço ou 1 (uma) dose, conforme situação vacinal.	
Idade recomendada	Adolescentes de 11 a 14 anos, independentemente de ter recebido anteriormente a vacina MenC (conjugada) ou dose de reforço.	
Conservação	Nível da temperatura	Tempo de duração
	Central +2°C a +8°C	Até a validade do produto. Utilizar imediatamente ou conforme orientação do laboratório.
	Regional +2°C a +8°C	
	Local +2°C a +8°C	
Via de administração	Intramuscular	
Volume da dose	0,5ml (ou conforme laboratório produtor)	
Duração da imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.	
Indicações	Na rotina para adolescentes de 11 a 14 anos.	
Contraindicações	Contraindicada para pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da vacina, incluindo o toxóide diftérico.	

Quadro 10. Características gerais da febre amarela

Agente etiológico	Vírus da febre amarela
Reservatório	O homem, os primatas e o mosquito transmissor.
Modo de transmissão	Picada do mosquito transmissor infectado.
Período de incubação	Três a seis dias, em média.
Transmissibilidade	De um a dois dias antes do início dos sintomas e durante os três a cinco primeiros dias da doença.
Suscetibilidade	Geral
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina; • Por anticorpos maternos, até o 6º mês de idade.

Quadro 10.1. Vacina contra febre amarela

Tipo de vacina	Vírus vivo atenuado		
Número de doses	1 (uma) dose aos 9 (nove) meses de vida, e uma dose de reforço aos 4 (quatro) anos de idade.		
Idade recomendada	▪ Crianças entre nove meses de vida a menores de cinco anos de idade: administrar duas doses aos nove meses de vida, e uma dose de reforço aos quatro anos de idade. ▪ Pessoas a partir de 5 (cinco) anos de idade, que receberam apenas uma dose da vacina antes de completarem 5 anos: administrar 1 (uma) dose de reforço. Respeitar o intervalo mínimo de 30 (trinta) dias. ▪ Pessoas a partir de 5 (cinco) a 59 anos de idade, não vacinadas: administrar 1 (uma) dose única.		
Conservação	Nível	Temperatura	Tempo de duração
	Central	+2°C a +8°C	Utilizar o frasco por até 6 horas após a diluição (varia conforme laboratório produtor e apresentação do frasco).
	Regional	+2°C a +8°C	
	Local	+2°C a +8°C	
Via de administração	Subcutânea		
Dose (volume)	0,5ml		
Eficácia esperada	Acima de 95%		
Duração da imunidade	Prolongada		
Indicações	• Para todos os indivíduos de 09 a 59 anos de idade. • A partir de 60 anos de idade a pessoa deve receber a vacina desde que: - apresentem risco elevado de adquirir febre amarela; - residam em área de mata, nas proximidades ou se desloquem para a área; - sejam avaliadas pelo serviço de saúde; - não tenham nenhuma contraindicação.		

Contraindicações/ precauções

- De modo geral, as vacinas de vírus vivos atenuados como é a vacina da febre amarela são contraindicadas durante tratamentos imunossupressores. São consideradas condições de imunossupressão:
 - Uso de corticosteroides: em doses superiores a 2 mg/kg/dia de prednisona ou equivalente para crianças e acima de 20 mg/kg/dia para adultos, por 14 dias ou mais;
 - Doença reumatológica: em tratamento com medicações antimetabólicas (por exemplo, a ciclofosfamida) ou com medicamentos modificadores do curso da doença (MMCDs) sintéticos, como metotrexato e ciclosporina;
 - Doença oncológica: idealmente vacinar antes do uso de drogas imunossupressores ou após três meses do término da quimioterapia;
 - Transplante de Células Tronco Hematopoiética: pelo menos 24 meses após o procedimento, caso não esteja com doença em atividade ou com necessidade de drogas imunossupressoras;
 - Transplante de órgãos sólidos: contraindicada no pós-transplante de órgãos sólidos em uso de drogas imunossupressoras.
- Aplicação simultânea com a vacina VTV para os casos de primovacinação em menores de dois anos:
 - Nestes casos, dar intervalo de 30 dias entre as doses das vacinas VTV e FA;
 - Em situações onde exista o risco epidemiológico concomitante para febre amarela e os vírus contidos na vacina tríplice viral, o risco da não vacinação é maior que a possibilidade da diminuição da resposta imune. Dessa forma a vacinação simultânea deverá ser realizada sem levar em conta o intervalo entre as doses;
 - Para a criança que recebeu anteriormente as vacinas tríplice viral e febre amarela, não há evidências de interferência na imunogenicidade entre elas, as duas poderão ser administradas simultaneamente ou sem intervalo mínimo entre as doses;
 - Se a criança recebeu apenas uma das vacinas (tríplice viral ou febre amarela), estabelecer preferivelmente o intervalo de 30 dias entre as doses (mínimo 15 dias);
 - Ressalta-se que a dose administrada deverá ser considerada válida e a dose de reforço deverá ser agendada conforme o Calendário Nacional de Vacinação vigente, de modo a respeitar o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

Eventos adversos	• Reações locais como: dor e abscesso; • Reações sistêmicas como: mialgia, mal-estar, dor de cabeça e febre entre 2 e 7 dias após a vacinação, com duração de um a três dias; • Reações de hipersensibilidade: foram relatados raros casos de erupção cutânea, urticária, bronco espasmo e reações anafiláticas, inclusive com choque, surgindo após a aplicação da vacina contra a febre amarela. Embora ocorrendo geralmente em pessoas com história de alergia a proteínas do ovo, outros componentes também podem deflagrar reações de hipersensibilidade; • Manifestações neurológicas: o mais grave dos eventos adversos neurotrópicos associados à vacina contra febre amarela é a encefalite, caracterizada por febre e manifestações neurológicas variadas (meningismo, convulsão, paresia) associadas a alterações liquóricas e iniciadas 7 a 21 dias após a vacinação.
-------------------------	--

Quadro 11. Características gerais do sarampo, da rubéola e da caxumba

SARAMPO	
Agente etiológico	Vírus do sarampo (<i>Paramixovírus</i>)
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	De pessoa a pessoa, pelas secreções nasofaríngeas.
Período de incubação	De 7 a 18 dias
Transmissibilidade	Desde o período prodrômico, em geral quatro dias antes, até quatro dias após o início da erupção.
Suscetibilidade	Universal
Imunidade	• Pela doença; • Pela vacina; • Por anticorpos maternos. Após os nove meses de idade, cerca de 80% das crianças já perderam esses anticorpos.

RUBÉOLA	
Agente etiológico	Vírus da rubéola
Reservatório	O homem
Modo de transmissão	Contato direto pelas secreções nasofaríngeas.
Período de incubação	De 14 a 21 dias, em média 17 dias.